TEMA 38 · Cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental. Otras alteraciones psíquicas. Prevención del suicidio. Valoración familiar y social. Apoyo al cuidador. Drogodependencias. Plan Nacional sobre Drogas

Resumen OPE Enfermería SMS · Examen del estado mental, NANDA en salud mental, contención mecánica, TCA, psicofármacos (litio, IMAO, antipsicóticos), riesgo suicida (SAD PERSONS, Código Riesgo Suicida de Murcia), Apgar familiar, Gijón, OARS, cuidador (Zarit), abstinencia alcohólica (CIWA-Ar), opiáceos y Plan Nacional sobre Drogas

1. Valoración en salud mental

- Base: **alianza terapéutica** (empatía, escucha, sin juicios) y el **examen del estado mental**:
- **Apariencia** y actitud (higiene, contacto visual).
- **Psicomotricidad**: agitación, inhibición, catatonía, **acatisia** (inquietud que obliga a moverse).
- **Curso del pensamiento**: taquilalia, bradilalia, bloqueos, **disgregación**, **fuga de ideas**.
- **Contenido**: ideas sobrevaloradas, obsesiones, **delirios** (creencias **falsas e irreductibles**: persecución, grandeza, celos, ruina).
- **Percepción**: **ilusión** (deformar un estímulo **real**) frente a **alucinación** (percepción **sin objeto**).
- **Afecto** (euforia, aplanamiento, labilidad) y **funciones cognitivas** (orientación, memoria, atención).
- **NANDA** frecuentes: **Ansiedad (00146)** y **Estrés por sobrecarga (00177)** son diagnósticos; **Nivel de ansiedad (1211)** y **Nivel de estrés (1212)** son **resultados NOC**. Afrontamiento ineficaz (00069), deterioro de la interacción social (00052), sufrimiento espiritual (00066), **Riesgo de suicidio (00150)** (diagnóstico de **riesgo**: tiene factores de riesgo, no relacionados).
- **Psicoeducación** al paciente y la familia para reconocer los **síntomas de recaída** y mejorar la adherencia.

2. Contención mecánica

- Medida **excepcional**, el **menor tiempo posible**, **nunca como castigo** ni por comodidad del equipo.
- Escalada previa: **contención verbal** (tono calmado, distancia de seguridad, ofrecer opciones, no discutir los delirios) → **medidas ambientales** (menos estímulos, medicación oral voluntaria) → **contención farmacológica** (antipsicótico ± benzodiacepina IM) → **mecánica**.
- La **indica el médico** por escrito en la historia; en urgencia extrema, **enfermería puede iniciarla** y avisa de inmediato al médico.
- Técnica: **4-5 personas** con roles asignados (una por extremidad y **el líder controla la cabeza**); sistemas homologados; **decúbito supino**; **cabecera elevada** (el manual indica **45°**) para evitar la **aspiración**; holgura de **dos dedos** entre correa y piel.
- Cuidados: vigilar **conciencia, vía aérea, respiración y constantes**; revisar la **perfusión** de las extremidades y la piel; hidratación, alimentación, eliminación e intimidad; **retirada progresiva**; después, **explicar al paciente** lo ocurrido y tranquilizar al resto de la unidad.

3. Otras alteraciones y psicofármacos

- **TCA** (ver Tema 32): explorar desnutrición, **hipopotasemia**, bradicardia, hipotensión, hipotermia, **lanugo**, **signo de Russell**; en el **patrón 9 de Gordon (sexualidad-reproducción)** recoger la **amenorrea** e historia menstrual. Cuidado con el **síndrome de realimentación**.

Fármaco	Riesgo	Cuidados
Litio (profilaxis del trastorno bipolar)	**Margen estrecho**: litemia **0,6-1,2 mEq/l**; **tóxico > 1,5** (temblor grosero, ataxia, disartria, diarrea, vómitos, confusión)	**Evitar deshidratación y dietas sin sal** (el riñón retiene más litio); controles de litemia
IMAO	**Crisis hipertensiva** con alimentos ricos en **tiramina**	Evitar **quesos curados, embutidos, ahumados, vino tinto, cerveza, habas, conservas**
Antipsicóticos típicos (haloperidol)	**Síntomas extrapiramidales**: distonía aguda (crisis oculógiras, tortícolis), acatisia, parkinsonismo, discinesia tardía	**Biperideno IM** en la distonía aguda
Antipsicóticos	**Síndrome neuroléptico maligno**	**Fiebre alta**, **rigidez en tubo de plomo**, inestabilidad autonómica y alteración de la conciencia: urgencia

4. Prevención del suicidio

- Continuo: **ideación** → **plan** → **intento** → suicidio consumado. La **depresión** es el trastorno más asociado; el **intento previo** es el **mejor predictor**; otros: alcohol, pérdidas, enfermedad crónica, **aislamiento**, sexo masculino.
- **SAD PERSONS** (1 punto cada ítem, máximo 10): **S**exo masculino, **A**ge (< 19 o > 45), **D**epresión, **P**revio intento, **E**tanol/drogas, **R**acionalidad perdida (psicosis), **S**oporte social escaso, **O**rganizado plan, **N**o pareja, **S**ickness (enfermedad).

Puntos	Actuación
0-2	Alta con seguimiento ambulatorio
3-4	Seguimiento estrecho y derivación **preferente** a salud mental
5-6	**Ingreso recomendado** (sobre todo sin apoyo social)
7-10	**Ingreso** obligado e inmediato, vigilancia continua

- **Región de Murcia**: **Estrategia de Mejora de la Salud Mental 2023-2026** y **Código Riesgo Suicida (CRS)** del SMS: tras un intento o con riesgo inminente, estabilización y **valoración por psiquiatría**; si no ingresa, al alta se activa el código: **cita preferente y seguimiento proactivo en su centro de salud mental**. Objetivos: detectar antes, homogeneizar, **reducir la repetición** y asegurar la **continuidad**. Muchos suicidas consultaron en AP o urgencias las semanas previas. En 2024: 105 suicidios en Murcia (tasa 6,7/100.000, ≈ 70% hombres). Programas: **BINA** (niños y adolescentes) y **ActivaMente** (AP: actividad física y grupos para el malestar de la vida cotidiana).

5. Valoración familiar y social

- **Apgar familiar (Smilkstein, 1978)**: autoadministrado, **5 preguntas** sobre la **satisfacción** con la familia: **A**daptación, **P**articipación, **G**rado de crecimiento (desarrollo), **A**fecto, **R**esolución (tiempo compartido). Se puntúa 0-2 cada una (0-10): **7-10 normofuncional**, 4-6 disfunción leve, 0-3 grave. Si hay disfunción: *procesos familiares disfuncionales* o *interrupción de los procesos familiares*.
- **Escala de Gijón**: mayores de 65 en la comunidad, **heteroadministrada**; 5 áreas (**familiar, económica, vivienda, relaciones sociales, apoyos**) de 1 a 5 (total **5-25**). Puntos de corte clásicos: < 10 aceptable, **10-14 riesgo social**, **≥ 15 problema social** (ver Tema 36). El manual de este tema cita un corte de riesgo **≥ 16** con **sensibilidad muy baja (15,5%)** y **especificidad muy alta (99,8%)**: pocos falsos positivos.
- **OARS (Universidad de Duke)**: recursos sociales (estado civil, convivencia, contactos, **persona de confianza**). Recursos **buenos** si hay alguien dispuesto a cuidarle **indefinidamente**; **medianamente deteriorados** si alguien puede cuidarle unas **6 semanas**; **muy deteriorados** si solo hay ayuda ocasional; **sin recursos**.

6. Cuidador principal

- Perfil: **mujer** (hija o esposa), ≈ 55 años, sin remuneración.

- **NANDA**: **Cansancio del rol de cuidador (00061)** si ya hay agotamiento; **Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062)** si hay factores de riesgo. **NIC**: aumentar el afrontamiento (5230), **respiro familiar**, delegar tareas.
- **Zarit** (Zarit 1980; validación española Martín 1996): **22 ítems de 0 a 4 → 0-88 puntos**; **≤ 46 no sobrecarga**, **47-55 leve**, **≥ 56 intensa**. Versiones abreviadas: **Bédard (12 ítems)** y **7 ítems** (en paliativos, sobrecarga intensa ≥ 17; ver Tema 36).

7. Drogodependencias

- **Adicción**: enfermedad **crónica y recidivante** del cerebro (sistema de **recompensa** mesolímbico, **dopamina**), no un problema de voluntad.
- Sustancias: **depresoras** (alcohol, opiáceos, hipnosedantes), **estimulantes** (cocaína, anfetaminas, nicotina, cafeína) y **perturbadoras/alucinógenas** (LSD, cannabis, psilocibina).
- **Abstinencia alcohólica**: hiperexcitabilidad (menos GABA, más glutamato): temblor, sudoración, ansiedad, **convulsiones** y **delirium tremens** (alucinaciones visuales). Tratamiento con **benzodiacepinas** (diazepam, lorazepam) y **tiamina**.
- **CIWA-Ar**: **10 ítems** (náuseas y vómitos, **temblor**, sudoración, agitación, ansiedad, alteraciones táctiles, auditivas y visuales, cefalea —cada uno 0-7— y **orientación** 0-4; máximo **67**). **No incluye constantes vitales** (pulso, TA, temperatura): si hay fiebre y confusión, descartar otras causas (infección, hemorragia). **< 8-10**: medidas de confort y control cada 8 h; **> 10**: benzodiacepinas y control **cada hora**.
- **Intoxicación por opiáceos**: **depresión respiratoria + coma + miosis puntiforme**. Soporte ventilatorio y **naloxona** (IV, IM o intranasal); su **vida media es corta (30-60 min)**: **vigilar la resedación**, **no dar el alta** al despertar.
- **Programas de mantenimiento con metadona** (agonista de larga duración, oral, **dispensación supervisada**): controlan el craving y la abstinencia sin euforia.
- **Patología dual**: trastorno por uso de sustancias **y** otro trastorno mental a la vez. **Reducción de daños**: **intercambio de jeringuillas** (VIH, VHC), **salas de consumo supervisado** (naloxona ante sobredosis).

8. Plan Nacional sobre Drogas (PNSD)

- Creado en **1985**; la **Delegación del Gobierno para el PNSD** depende del **Ministerio de Sanidad**; se rige por la **Estrategia Nacional sobre Adicciones**.
- **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)**: **EDADES** (población **15-64 años**, bienal) y **ESTUDES** (estudiantes de **14-18 años**, bienal; mide la edad de inicio).
- Sustancias más consumidas: **alcohol** > **tabaco** > **hipnosedantes** (más en **mujeres**) > **cannabis** (**droga ilegal más consumida**). Inicio ≈ **14 años** con alcohol y tabaco; cannabis ≈ 15.
- **Prevención** (clasificación de Gordon): **universal** (toda la población, p. ej., un colegio), **selectiva** (**grupos vulnerables** que aún no consumen: hijos de alcohólicos, menores tutelados) e **indicada** (personas que **ya consumen** o tienen problemas iniciales, sin dependencia).
- **Adicciones sin sustancia**: juego (apuestas online), videojuegos, internet; las **cajas de botín** (*loot boxes*) como puerta al juego.
- **Fondo de bienes decomisados** por narcotráfico: **Ley 17/2003**; reparte los fondos la **Mesa de Coordinación de Adjudicaciones** (prevención, asistencia y reinserción).

TRAMPAS DE EXAMEN

- ! Ilusión = estímulo real deformado; alucinación = **sin estímulo**.
- ! Nivel de ansiedad (1211) es **NOC**; Ansiedad (00146) es **NANDA**.
- ! Contención: **último recurso**, **decúbito supino**, cabecera elevada, 4-5 personas, el líder **sujeta la cabeza**.
- ! Litio **0,6-1,2**; tóxico **> 1,5**; **nunca dieta sin sal** ni deshidratación.
- ! IMAO: **nada de tiramina** (quesos curados, embutidos, vino tinto).
- ! Distonía aguda por haloperidol → **biperideno**.
- ! **Intento previo** = mejor predictor de suicidio; SAD PERSONS **≥ 5** → ingreso recomendado.
- ! Apgar familiar: **5 preguntas**, satisfacción con la familia.
- ! Zarit: **0-88** (ítems de 0 a 4).
- ! CIWA-Ar **no mide constantes vitales**.
- ! Naloxona dura **menos** que el opiáceo: **vigilar la resedación**.
- ! Prevención **selectiva** = grupo vulnerable que **no consume**; **indicada** = **ya consume**.
- ! Droga ilegal más consumida: **cannabis**; hipnosedantes: más en **mujeres**.